EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	93640
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2024-09-28 11:54:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUANA ROSA MU OZ DE LA FUENTE			RUN	: 5.187.330-0
F.Nac	: 11-08-1946	Edad	: 78 AÑOS, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	: MONTE LEON ACT			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 940551015		
Fecha Ingreso	: 2024-09-26	Fecha Egreso	: 2024-09-28 11:54:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D42.9-TUMOR DE COMP. INC. O DESC. DE LA MENINGES, PARTE NO ESPECIF

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico en estudio, topografía en estudio (obs centro semioval-corona radiada izquierda), etiología ATE intracraneano vs cardioembolía
-Tumor occipital mesial izquierdo, obs 1° SNC
-Ant: HTA - mRS 1

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente BEG, HDN estable con HTA moderada en control progresivo, RS al monitor, eupneica, afebril, evaluación fonoaudiológica concluye disfagia orofaringea ilógica con necesidad de mantener SNG
para ingesta líquidos y papilla por boca, no refiere molestias, impresiona clínicamente mejor que al ingreso. Sin RAM por DAPT.
Describe episodio: mientras lavaba ropa de pie presentó disartria y paresia BC derecha súbitas, asociadas a hipoestesia BC ipsilateral, cefalea frontal alta no ictal leve y palpitaciones.
AngioTC cerebro y cuello: estenosis >50% origen M1 izquierda (y placa de ateroma en su 1/3 medio), M2 posterior derecha, V4 izquierda y 1/3 medio-distal de AB; tumor nodular occipital mesial izquierdo calcificado con leve efecto de masa sobre esplenio y cuerno occipital ipsilaterales; no observo lesiones agudas evidentes.
TC cerebro c/c: impresiona posible lesion isquémica aguda en centro semioval-corona radiada izquierda, micronagiopatía confluente de predominio occipital, dificil determinar si existe edema vasogénico alrededor de tumor occipital, si asi fuese es de escasa magnitud; pared del tumor de centro quístico presenta escasa captación de contraste, no impresiona origen metastásico.
PanTC describe presencia de diverticulosis no complicada, ateromatosis aórtica, hernias en la pared abdominal y quistes renales simples bilaterales; TC de tórax impresiona sin lesiones sugerentes de neoplasia, derrame pleural, neumotorax ni condensación pulmonar.
Exs de lab de ingreso y control destaca sólo B12 límite sin hallazgos significativos.
TC cerebro s/c de control de hoy no muestra una lesión aguda claramente evidente, principalmente por la presencia de microangiopatía.
Pendiente realizar ETT y Holter de ritmo.
Diuresis(+) dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 28/9/24 para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica por HODOM, y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-15 días.

PLAN DE MANEJO:

-RM cerebro c/c, ETT, Holter de ritmo ambulatorios
-Alta a domicilio el 28/9/24 para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica por HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Clopidogrel 75 mg/día
3. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
4. -Famotidina 40 mg/día
5. -Losartan 50 mg c/12h

6. -Amlodipino 10 mg/día
7. -Hidroclorotiazida 50 mg/día
8. -Carvedilol 6.25 mg c/12
9. -Levetiracetam 500 mg c/12h

EXÁMENES Y RESULTADOS

27/9/24
-Alb 3.8
-Crea 0.6 MDRD 96.69 Uremia 58
-Na 142 K 4.3 Cl 105
-Leu 8200 Hb 14 Plaq 211000 VHS 15
-TSH 0.733 T4L 1.12
-B12 222 Folato 19
-RPR N/R
-Hb glic pendiente

25/9/24
-Glic 136
-Crea 0.4 MDRD 154.37 Uremia 68
-PCR 7.5
-Na 141 K 4.6 Cl 107
-Hb 14.8 Leu 9600 Plaq 245000 Seg 67
-INR 1.01 TTPA 28
-Trop 15.4
-OC Leu 5-10

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) sibilancias espiratorias muy ocasionales
-Abd: BDI, RHA(+), globuloso, hernia umbilical no complicada
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos +/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N, distingue derecha-izquierda cruzando linea media
-PC: CV por amenaza impresiona conservada, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha leve, disartria leve, nistagmo(-), pares bajos impresionan N
-Motor: PPP(-), RCP flexor bilateral
-Sensibilidad: impresiona conservado
-Cerebelo: impresiona conservado
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO